

גילוי והסתרת מידע ממטופל

אשר טרגין · קורס אחות מטופל — אתיקה רפואית לאור ההלכה

מבוא: השאלה המרכזית

עד כמה חייב הרופא לגלות לחולה את מצבו האמיתי? שתי גישות עיקריות עומדות זו מול זו בתולדות הרפואה: הגישה הפטרנליסטית הקלאסית, מול עקרון האוטונומיה המודרני. הגישה הפטרנליסטית מיוצגת כבר בכתבי היפוקרטס (המאה החמישית לפני הספירה): "מלא חובותיך לחולה בשלוח וביעילות, תוך העלמת רוב הדברים מן החולה בעת טיפולך בו... לעתים עליך להסיט את תשומת לבו... ולעתים עליך להניח את דעתו בשכנוע ובהאזנה, בלי לגלות לו דבר על מצבו." גם הרמב"ם, באגרת תימן, כותב שכשם שהחולה הסכל סומך על אומן המלאכה הרפואית, כך על הרופא לנהוג ולקבל ממנו מה שיאמר לו. אולם החוק המודרני — חוק זכויות החולה — הפך את הכיוון: המטופל זכאי למידע רפואי מלא, כולל אבחנה, פרוגנוזה, סיכונים וחלופות, כתנאי להסכמה מדעת.

איסור השקר בכללותו

היסוד ההלכתי הבסיסי הוא כמובן איסור השקר: "מְדַבֵּר שֶׁקֶר תִּרְחֹק" (שמות כג, ז). חז"ל מדגישים את חומרתו: "ארבע כתות אינן מקבלות פני שכינה: כת ליצים, כת חנפים, כת שקרנים... וכת שקרנים" (סנהדרין קג.), ובאותו מקום: "כל מי שהוצא להוט אחר השקר אינו ראוי לדור בעולם! מפני שבראתי העולם באמת, ואין שקר דר אצל אמת."

מותר לשנות מפני השלום — היתר מוגבל

ההלכה מכירה בכמה חריגות מוגדרות לאיסור השקר. הגמרא ביבמות (סה:; קובעת: "מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום", ומביאה כמה מקורות — יוסף ואחיו, ר' נתן הלומד ממעשה שמואל, ודברי בי רבי ישמעאל: "גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו" (בין תיאורי דבריו של שרה לפני ואחרי, בבראשית יח). הקטגוריות המוכרות של היתר שינוי הן: פיקוח נפש — סכנת חיים מתירה שינוי מהאמת, מכוח אותו כלל "וחי בהם ולא שימות בהם" (יומא פה:); מפני השלום — שמירת שלום בין אנשים; וענווה וצניעות — כפי שאברהם אמר על שרה "אחותי היא" כדי לא לגלות שהיא אשתו (רש"י, בראשית כ, יב), ועיין ברש"י שם על הקשר המשפחתי המדויק שאפשר לתאר בדרך זו בלא שקר גמור.

החפץ חיים בהלכות רכילות (כלל א) מוסיף כלל חשוב: כשמישהו שואל מה נאמר עליו, ואם אין דרך להשיב באופן שאינו שקר גמור ואינו רכילות — מותר לומר שקר

גמור מפני השלום, אך אין להישבע חלילה לשם כך. ועם זאת, ספר חסידים (סימן תרמב) מזכיר עקרון מסייג חשוב: גם כאשר יש היתר לשנות, יש להמעט בשינוי ככל האפשר — ולדוגמה, כשיעקב אמר "אֲנִי עֹשֶׂה בְּכַךְ", רש"י מפרש שכוונתו הייתה "אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך" — שינוי מינימלי, לא שקר טוטלי.

הלכות מסירת בשורות רעות

ישום ישיר של עקרונות אלה מצוי בהלכות מסירת ידיעה על מות קרוב לחולה. השולחן ערוך (יורה דעה, שלז, א) פוסק: "חולה שמת לו מת — אין מודיעין אותו, שמא תיטרף דעתו עליו... שלא ישבר לבו." ומדרש קהלת רבה מציין שאפילו ישעיהו הנביא לא אמר לחזקיהו המלך "כי מת אתה" במפורש, כדי שלא ייחלש. באשר לאמירת וידוי לחולה הנוטה למות, נחלקו הפוסקים: הב"ח סבר שאין לומר וידוי למי שאינו נוטה למות, אך בנוטה למות — יש לומר, שאם לא יאמרו עכשיו לא יאמרו לעולם; הח"א (חכמת אדם) תולה זאת במנהג המקום.

סיפור חזאל — חצי אמת מגן

סיפור המקרא בספר מלכים (ב, ח) על שליחות חזאל לאלישע מדגים היתר קרוב לענייננו: כשבן הדד מלך ארם שלח את חזאל לשאול את אלישע אם יחיה מחוליו, אלישע עונה לו: "לֵךְ אֶמַר לוֹ [לבן הדד]: הִיָּה תְּחִיָּה" — אך מגלה לחזאל עצמו שהמלך בעצם ימות. חזאל אכן מוסר לבן הדד את המסר המרגיע ("הִיָּה תְּחִיָּה"), אף שבמעשה עצמו הוא ממית את בן הדד למחרת. הפרשנים דנים ביחס בין דברי אלישע לבין המעשה, אך המבנה עצמו — הבחנה בין מה שנאמר למטופל/למלך לבין מה שידוע לצוות המטפל — עומד ברקע הדיון ההלכתי המודרני על גילוי אבחנה.

המקרה המודרני: חולה סרטן ובקשת בני משפחה

שאלה נפוצה בפני הרבנים: חולה נגוף במחלת סרטן, המבקש מאחרים ומצווה על בנו לא לגלות לו מה מחלתו יצייתו לו? מקורות שונים דנים בסוגיה זו. חלק מהפוסקים (כגון שו"ת ציץ אליעזר) מבחינים בין חובת הרופאים לגלות מידע לחולה עצמו (לפי שיקול דעת רפואי-הלכתי זהיר) לבין חובת הבן כלפי אביו — כשמצווה לבנו בתורת כבוד אב שלא לגלות לו על מחלתו, אסור להבן לגלות לו.

הרב אברהם שטיינברג בספרו נשמת אברהם מציג עמדה שמשקפת שינוי דורי: "היום שלמעשה קשה מאוד להסתיר מחולה סרטן את טיב מחלתו... ואם לא מגלים לחולה באופן ישיר את טיב מחלתו... הוא ודאי יחשוב על מצבו על הצד הגרוע ביותר, ואדרבא — האי ידיעה, ויותר גרוע הידיעה הלא נכונה והמוטעית, תביא אותו ליאוש ולשברון הלב." כלומר, בעידן שבו שיעורי ההצלחה בטיפול עולים וההסתרה

כמעט בלתי אפשרית מעשית, ידיעה חלקית או שגויה עלולה לגרום נזק גדול יותר מן הגילוי המדויק.

הרב פרופ' יגאל שפרן, בכתב העת אסיא, מוסיף שיקול מערכתי: אם ייודע לחולים שהמנהג הרווח בקרב הרבנים, הרופאים ובני המשפחה הוא להסתיר תמיד את האמת מהחולה — דווקא כך ייהרס אמונם במערכת הרפואית כולה, לטוב ולמוטב.

חמישה שלבי אבל וגישת קובלר-רוס

מחקרים פסיכולוגיים מודרניים (מודל קובלר-רוס) מתארים חמישה שלבים שעוברים חולים נוטים למות: הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון, וקבלה. עיקוב שוגה מציאות האבחנה עלול לגרום לחולה להיתקע בשלב ההכחשה או לעבור אותו באופן מעוות, ולכן גישות רפואיות עדכניות מדגישות תקשורת מדורגת עם החולה תוך תמיכה רגשית והכוונה — ולא הסתרה גורפת או גילוי גס וחסר רגישות.

חוק זכויות החולה — המסגרת המשפטית

סעיף 13 לחוק זכויות החולה קובע שלא יינתן טיפול רפואי אלא בהסכמה מדעת, וכי המידע הרפואי הנדרש כולל אבחנה, פרוגנוזה, מהלך הטיפול, תועלתו הצפויה, סיכונים וחלופותיו. עם זאת, סעיף 13(ד) מאפשר לרופא להימנע ממסירת מידע מסוים אם ועדת אתיקה אישרה שמסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל — כלומר, גם החוק החילוני מכיר בחריג מוגבל, שדומה במבנהו לחריג ההלכתי.

שקר לטובת המטופל — טיעונים בעד ונגד

הצד המצדד בשקר רפואי לטובת המטופל מעלה שני נימוקים: השגת טיפול חיוני — לעתים השקר מאפשר קבלת טיפול חיוני שאין דרך אחרת להשיגו (למשל כלפי גורמי ביטוח או בירוקרטיה, שנתפסים כ"מערכת" ולא כאדם פרטי); ותיקון אי-שוויוניות — מערכת הבריאות עצמה אינה תמיד שוויונית, ולעתים פוגעת בחולים חלשים.

הצד השולל מעלה שלושה נימוקים נגדיים: חובת הרופא כלפי המטופל — הרופא מחויב בראש ובראשונה לאמת ולבריאות המטופל, ולא לכל אמצעי אחר; פגיעה באמון — הקשר בין רופא למטופל מבוסס על אמון מוחלט, ופגיעה בו עלולה לחזור ולהזיק למטופל עצמו בעתיד; ומעשה פסול כשלעצמו — שקר פסול עקרונית, בלתי תלוי בתוצאה, ועלול להפוך את המטופל עצמו לשותף למרמה; ופגיעה במערכת כולה — שקר שיטתי מערער את אמינות מערכת הבריאות בכללותה.

סיכום

המתח בין חובת האמת לחובת ההגנה על החולה מלווה את הרפואה מימי היפוקרטס ועד ימינו. ההלכה מציעה מסגרת מאוזנת: איסור שקר חמור ביסודו, לצד חריגים מוגדרים היטב – פיקוח נפש, שלום, וענווה – הכפופים לעקרון "ואם משנים, ממעטים בשינוי." בעידן הרפואה המודרנית, שבו שקיפות ואוטונומיה הפכו לערכי יסוד, הנטייה ההלכתית והמעשית כאחד היא לצמצם את ההסתרה למינימום ההכרחי, ולהעדיף גילוי זהיר ומדורג על פני הסתרה גורפת – לא מפני שהאמת חשובה פחות, אלא מפני שהניסיון מלמד שהיא לרוב הדרך הטובה יותר לגלות אחריות, אמון וחמלה כלפי החולה.